**جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) ***

# طلب علاج أول مرة / متردد

**إسم المريض رباعياً :** اسامه ادولف مرقس غبرانيوس
**المحافظة :** سوهاج **الحي / المدينة :** اخميم **العنوان :** ...
**رقم البطاقة :** 27001022600093 **رقم التليفون :** 01205634630 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
**العمر(تاريخ الميلاد) :** 02-01-1970 **المهنة :** حاصل علي دبلوم

## الإقرار

**أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك**

**الإخصائي الاجتماعي** **المقر بما فيه**
**التوقيع:**(----------) **التوقيع:**(----------)

**التشخيص الإكلينيكي :** ورم خبيث بالمستقيم
**نتائج الأبحاث :** (مرفق)
**التشخيص النهائي :** ورم خبيث بالمستقيم
**خطة العلاج :** أورام كيماوي خط علاج كيمائي للورم المنتشر طبقا لبروتوكول (Folfox) [14238] **قسم العلاج :** الاورام
**التعليق على التشخيص :** ----------

## تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

**الاسم:** د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

**أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.**
**كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.**

**تعتمد صحة البيانات المرفقة**
**رئيس اللجنة و مدير المستشفي.**

**تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.**

## أعضاء اللجنة

**ا.د/** ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

## قرار اللجنة

**التشخيص النهائي :** ----------
**خطة العلاج :** ----------
**المستشفي :** ----------**قسم :** ----------
**جهة العلاج :** ----------**نفقات :** ----------
**ملاحظات :** ----------

| رئيس | مدير عام | ختم |
|---|---|---|
| المجلس الطبي المتخصص | مديرية الشئون الصحية | شعار الجمهورية |

**Name:** اسامه ادولف مرقس غبرانيوس
**National ID:** 27001022600093

## تقرير طبي

**السيد**

**تحية طيبة وبعد,,**

| | |
|---|---|
| **إيماء للطلب المقدم من** | **بشأن تقرير طبي للمريض** |
| **بقسم:** | **رقم طبي:** |

**نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته**

| | |
|---|---|
| **تاريخ وساعة الدخول :** -- --:-- yyyy-mm-dd | **تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026 |

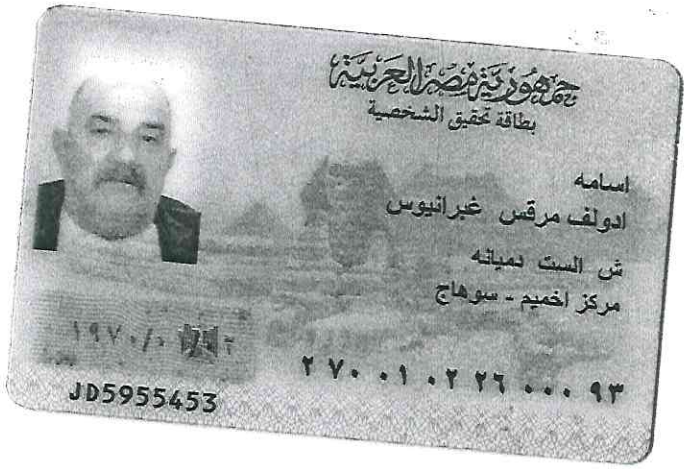
**وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة**

**A patient of colorectal cancer for FOLFOX Chemotherapy Protocol**

| | |
|---|---|
| **التاريخ :** 05-07-2026 | **الوقت :** -- --:-- |
| | **الطبيب المعالج :** د/شيماء لاشين |




٠١٢٠٥٦٢٤٦٣٠
٠١٢٧٢٩٤٥٠٢٦



مركز العارف للأشعة التشخيصية
أ. د/سعد رزق الجبالى
استاذ الاشعة التشخيصية
كلية طب الازهر

REFERRING PROF DR; AHMAD ABDEL RAHMAN AL SHEIKH
Thanks for your reference .
PATIENT'S NAME; USAMA ADOULF MURQOUS AGE; 54 YRS.
1 June 2026
EXAMINATION;MS TRIPHASIC CT SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS WAS PERFROMED AFTER ORAL AND IV CONTRAST ENHANCEMENT .

Indication, anal bleeding since few months .
Findings ; The study has revealed diffuse annular mural thickening involving the anal canal , rectum and sigmoid colon . The involved segments starts at anal orifice and extends for average 15 cm above it , to reaches the sigmoid colon . It has average 1 to 3 cm wall thickness . It results in marked luminal narrowing . It infiltrates whole layers of the involved segments and invades the related fat planes .
Associated multiple enlarged lymph nodes are noted along pelvic iliac , upper para aortic and porta hepatis groups with average 1 to 2 cm . Associated Mild enlarged left adrenal gland is noted, measuring about 1.5 cm .
Mild prominent gastric mucosal folds are noted for upper endoscopy assessment .
The visualized liver is within average size and density.
Solid focal lesion is noted at segment VI of right lobe , measuring about 2x3 cm and show progressive enchancement along arterial , venous and delayed phases , likely related to hemangioma . No dilated biliery radicles.
The gall bladder has no stones or masses could be detected .
The spleen has average size . No focal lesions .
The other retroperitoneal structures including the kidneys , pancreas and right adrenal gland appear intact .
Average appearance of the urinary bladder and prostate is noted . No ascites could be detected .
**IMPRESSION;** Highly suspicious Aggressive long mural thickening involving the recto sigmoid colon and anal canal with local and lymphatic spread .For clinical correlation , tumouer markers with histopathology assessment , PET CT and follow up .

MUCH OBLIGED:
DR; SAAD REZK .(M.D)

سوهاج – ش الشهيد- خلف المطافى والاسعاف - برج المهندسين - الدور الارضى
ت:- 093/2128146موبايل 01148157804
الخدمات بالمركز: الاشعة المقطعية- بانوراما الاسنان -ماموجرافى للثدى - الديكسا لقياس هشاشة العظام

| | |
|---|---|
| **Name:** اسامه ادولف مرقص غبرانيوس<br>**MR. :** 11614 | |

Detailed Medical Report

**السيد**

**تحية طيبة وبعد,,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **إيماء للطلب المقدم من** | | **بشأن تقرير طبي للمريض** | |
| **بقسم:** | | **رقم طبي:** | |

**ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تاريخ وساعة الدخول :** | | **تاريخ وساعة الخروج :** | |

**وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه**

**Bleeding per rectum; colonoscopy on 22/5 revealed a large cauliflower-shaped ulcerated mass 2 cm from the anal verge. PET/CT showed mural thickening of the lower rectum extending 9 cm with perirectal fat smudging, SUV 35.8, small bilateral internal iliac lymph nodes, and basal pulmonary nodules 7 mm. Biopsy was taken; result pending. A portacath was placed and new lines were inserted.**

**Biopsy received on 06/07/2026 showed intramucosal adenocarcinoma, grade 2.**

**CT scan on 01/06/2026 demonstrated diffuse annular mural thickening involving the anal canal, rectum, and sigmoid colon. The involved segment starts at the anal orifice and extends approximately 15 cm above it, reaching the sigmoid colon. Wall thickness averages 1–3 cm, resulting in marked luminal narrowing. The lesion infiltrates all layers of the involved segments and invades adjacent fat planes. Multiple enlarged lymph nodes are noted along the pelvic iliac, upper para-aortic, and porta hepatis regions. Slide review is pending; a new CT scan and MRI rectal protocol are planned.**

**MRI abdomen and pelvis with contrast on 23/08/2026 revealed annular mural thickening and a mass lesion involving the anal canal, measuring 10 × 4 × 4 cm with an average wall thickness of 2 cm. The mass causes marked luminal narrowing and proximal rectal distension, likely obstructing. The mass starts at the anal orifice and extends to the anorectal junction above the levator ani level. No distant metastases or enlarged lymph nodes were identified on CT chest. Pathology review on 29/08/2026 confirmed intramucosal carcinoma with associated tubular-villus adenoma with high-grade dysplasia.**

**تحريرا في ,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **التاريخ :** | **20-09-2026** | **الوقت :** | |

**الطبيب المعالج :** حنان عزت شفيق تاودروس

**يعتمد ,**

مركز العارف للأشعة التشخيصية
أ. د/سعد رزق الجبالى
استاذ الاشعة التشخيصية
كلية طب الازهر

**REFERRING PROF DR; AHMAD ABDEL RAHMAN AL SHEIKH**
**Thanks for your reference .**
**PATIENT'S NAME; USAMA ADOULF MURQOUS AGE; 54 YRS.**
**1 June 2026**
**EXAMINATION; MSCT SCAN OF THE CHEST WAS PERFROMED WITHOUT IV CONTRAST .**

## REPORT

LUNGS ; The visualized Both lung fields are well inflated.
Two nodules are noted at apical segment and lateral basal segment of right lower lung lobe .
Fibrotic band is noted at lingula .
No definite mass lesions could be detected .
PLEURAL SACS ; The pleural sacs and recesses appear intact.
No effusion or masses could be detected .
MEDIASTINAL STRUCTURES ;
The mediastinal vascular structures are within average limits.
No masses could be detected .
LYMPHATIC SYSTEM ;
Two small sized mediastinal lymph nodes are noted at aorto pulmonary level with average 1 cm .
CHEST WALL ;
The bony chest wall appears intact .
No muscle masses could be detected .
Average appearance of the breasts is noted .
LOWER NECK AND THORACIC INLET ;
No definite goiter could be detected .
UPER ABDOMEN ;
Average appearance of the involved upper abdominal organs is noted .

**IMPRESSION;**

Two nodules noted at apical segment and lateral basal segment of right lower lung lobe of no definite nature , might be granulomas / deposits .
Two small sized mediastinal lymph nodes at aorto pulmonary level .
For clinical correlation , tumouer markers , PET CT assessment and follow up .

**MUCH OBLIGED:**
**DR; SAAD REZK .(M.D)**

سوهاج – ش الشهيد- خلف المطافى والاسعاف - برج المهندسين - الدور الارضى
ت:- 093/2128146موبايل 01148157804
الخدمات بالمركز: الرنين المغناطيسى المفتوح - الاشعة المقطعية- بانوراما الاسنان -ماموجرافى للثدى - الديكسا لقياس هشاشة العظام

**Date: Friday, May 22, 2026**
**Name: Osama Adoulf Morkous** **Age: 56 years**
**Referred by: Dr. David Magdy Metry**
**Indication of colonoscopy: Rectal polyp for polypectomy.**
**Pre-endoscopic medication:** Buscopan amp and propofol.
**Endoscopic biopsy: Yes.**

# Colonoscopy Report

**Preparation:** Good.

**Procedure:**

Introduction of the colonoscope was done while the patient is lying on his left side, sedated by propofol, up to the cecum.

- The colon shows large polypoidal cauliflower ulcerated mass 2cm from anal verge extending to 7cm from anal verge friable and easily bleeds on touch; multiple biopsies were taken for histopathological examination **(Bottle C).** A part from that the remaining examined part of the colon shows normal mucosa and normal vasculature, with no visible ulcers, masses or polyps.
- Retroversion was free.

**Conclusion:**

- **Large polypoidal cauliflower ulcerated mass 2cm from anal verge extending to 7cm from anal verge friable and easily bleeds on touch; multiple biopsies were taken for histopathological examination (Bottle C).**

**Signature**
*DR/David Magdy Metry,MSc.*
*Specialist of Hepatogastroenterology*

معامل الخليـة
لتحاليل الأنسجة والأورام

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Patient Name** | اسامه ادولف مرقس غبرانيوس | **Code Number** | YK 26008629 |
| **Sex/Age** | Female 56 Y 2 M 23 D | **Patient ID** | 87530 |
| **Registered Date** | 25/3/2026 01:01:10 PM | **Referred By Dr.** | - |
| **Validation Date** | 01/4/2026 03:36:44 PM | **Branch** | سوهاج الشهيد |
| **Reporting Date** | 01/4/2026 05:15:27 PM | | |

**Clinical Diagnosis:** Anal Canal Mass
**Nature of the specimen:** Biopsy

# Pathology Report

## Gross Picture

Polypoidal tissue piece measured 0.5x0.5 cm, bisected and totally submitted with inked resection margin.

## Microscopic Picture

The examined serial sections from the received colonic biopsy revealed multiple polypoid pieces with elongated villi lined by dysplastic columnar epithelium exhibiting stratified rounded elongated basal nuclei and mild decrease in mucus secretion. The intervening lamina propria was inflamed and no desmoplastic reaction. No malignancy seen in sections examined within the limits of the received biopsy.

## Diagnosis

*Anal Canal Mass, Biopsy:*

- **Low Grade Dysplastic Villous Adenoma (0.5x0.5 cm), For Close Follow Up.**
- **No Reported Invasive Malignancy In Current Tissue.**
- **Yet, If Malignancy Is Strongly Suspected Deeper, Representative Rebiopsy Is Highly Recommended.**
- **For Clinico-Radiologic Correlation.**

## P.O

Number of slides enclosed: 1

## Diagnosed by

**Consultant Pathologist**
*Dr. Mona Sakr, MD*

Scan Me

الفرع الرئيسي الدقي : ٢٠ شارع التحرير أمام مترو البحوث - الدقي - الدور الأول
م: ٠١١١٢٤٤٣٣٣ - ٠١١١١٥٥٧١١٧ - ت: ٠٢٣٣٣٥٣٠٧٣